

 GUIA GRATUITO

CRC ELITE

O MÉTODO PARA
**TRANSFORMAR LEADS
EM PACIENTES**
E MANTER A AGENDA
DA SUA CLÍNICA
SEMPRE LOTADA



MAIS AGENDAMENTOS
E COMPARECIMENTOS



RELACIONAMENTO
QUE GERA CONFIANÇA



MAIS TRATAMENTOS
E FATURAMENTO



MENOS FALTAS,
MAIS RESULTADOS

LOOKLEAD
MARKETING • CRM • DADOS • RESULTADOS



ESTRATÉGIAS PRÁTICAS
PARA UMA CRC DE
ALTA PERFORMANCE





CRC ELITE

O método para transformar leads em pacientes e manter a agenda da sua clínica sempre lotada

UMA PUBLICAÇÃO

Looklead Marketing e Performance

Guia gratuito para donos e gestores de clínicas odontológicas e médicas.

SOBRE ESTA EDIÇÃO

Primeira edição, agosto de 2026.

Este material reúne o conhecimento acumulado em 9 anos de operação da Looklead, mais de R\$ 8 milhões geridos em anúncios e mais de R\$ 300 milhões em receita gerada para nossos clientes em 200 empresas atendidas.

COMO USAR ESTE GUIA

Este ebook foi estruturado para ser lido em duas passagens. A primeira, do início ao fim, para você entender a lógica completa. A segunda, capítulo a capítulo, com sua equipe, para implementar cada bloco na sua clínica. Ao final de cada parte você encontra um plano de ação prático.



DIREITOS E USO

Este material é distribuído gratuitamente. Você pode compartilhá-lo com sua equipe, imprimir e utilizá-lo internamente. Redistribuição comercial não é permitida. Para citação, use: LOOKLEAD. CRC Elite: o método para transformar leads em pacientes. São Paulo: Looklead, 2026.



Uma carta antes de começar

Se você chegou até aqui, provavelmente já viveu esta cena.

Você fecha o mês olhando para o relatório da agência de marketing e vê números bonitos. Leads captados, cliques, impressões. E, ao mesmo tempo, olha para o Google Calendar da sua clínica e vê janelas vazias. Consultas que não foram agendadas. Pacientes que sumiram entre o formulário do site e a cadeira do consultório.

Se essa cena te é familiar, você não está sozinho. É a realidade da maioria das clínicas que passam pela Looklead antes de virar cliente.

O problema quase nunca é falta de lead. É o que acontece com o lead depois que ele chega.

"Você não tem um problema de marketing. Você tem um problema de sistema."

Este ebook é sobre esse sistema. Especificamente, sobre a peça que quase toda clínica ignora: a CRC. Central de Relacionamento com o Cliente. Ela existe em dois planos que quase sempre são confundidos: o operacional (a recepção que atende, agenda e faz confirmação) e o comercial (a função que qualifica leads, apresenta tratamentos e transforma interesse em consulta paga).

Nas próximas 30 e poucas páginas, você vai aprender a estruturar essas duas frentes de forma que uma alimente a outra. Vai receber scripts que a gente aplica todos os dias com os clientes que atendemos, checklists prontos para você imprimir, e indicadores para medir se a coisa está funcionando.

Nada aqui é teoria de livro. É o que a Looklead viu funcionar em mais de 200 empresas, gerando mais de R\$ 300 milhões em receita. Se você aplicar, mesmo que só metade, a agenda vai começar a mudar de cara em 30 dias.

Boa leitura.

Juliano Poletti

Fundador da Looklead



Sumário

PARTE I · DIAGNÓSTICO

Por que sua agenda está furada

- 01 O que é uma CRC e por que ela existe
- 02 As duas naturezas da CRC: operacional e comercial
- 03 Os 7 furos silenciosos que destroem sua conversão
- 04 Como medir se a sua CRC funciona: 12 indicadores

PARTE II · CRC OPERACIONAL

A recepção que agenda, confirma e reduz faltas

- 05 SLA de atendimento: a regra dos 5 minutos
- 06 Confirmação em 3 toques: como reduzir no-show em 40%
- 07 Recuperação de pacientes inativos: a mina de ouro esquecida
- 08 Scripts prontos: WhatsApp, ligação, e-mail e áudio

PARTE III · CRC COMERCIAL

A função que transforma lead em paciente pagante

- 09 SDR e Closer: quem faz o quê
- 10 Cadência de 9 toques que converte 3x mais
- 11 Como apresentar tratamento: técnicas de venda consultiva
- 12 Objeções mais comuns e como responder

PARTE IV · IMPLEMENTAÇÃO

Como sair do zero e estruturar uma CRC de alta performance em 30 dias

- 13 Roadmap de 30 dias, semana por semana
- 14 Ferramentas essenciais (CRM, WhatsApp Business, planilhas)
- 15 Como treinar seu time em 5 dias



16 Cases reais: como Sorrix, CECAM e The Wand chegaram lá

Encerramento: seu próximo movimento



Introdução

Duas cenas para começar

Cena 1. Uma clínica odontológica em São Paulo investe R\$ 12 mil por mês em tráfego pago. Recebe 180 leads. Fecha 4 tratamentos no mês. Custo de aquisição por paciente pagante: R\$ 3.000. O dono demite a agência, culpa o tráfego, e volta a depender de indicação.

Cena 2. Uma clínica médica no Rio de Janeiro investe R\$ 4 mil por mês em tráfego pago. Recebe 60 leads. Fecha 9 tratamentos no mês. Custo de aquisição: R\$ 444. O dono aumenta o investimento e escala.

Duas clínicas, mesma cidade grande, mesmo perfil de paciente. Uma quebra. A outra escala. A diferença não está no tráfego. Está no que acontece entre o formulário preenchido e a consulta concluída.

A diferença está na CRC.

O que este ebook vai te dar

1. Um diagnóstico honesto dos 7 furos mais comuns na CRC de clínicas brasileiras.
2. Os KPIs certos para você medir se sua CRC funciona (e não os que a agência costuma reportar).
3. Scripts prontos de WhatsApp, ligação e e-mail para agendamento, confirmação e reengajamento.
4. Uma cadência comercial de 9 toques que triplica a taxa de conversão de lead em paciente.
5. Um roadmap de 30 dias para implementar tudo, sem contratar ninguém novo.

O que este ebook não é

Não é um livro de teoria de marketing. Não é sobre gestão de tráfego. Não é sobre branding. Se você quer entender como estruturar campanhas de anúncios, esse conteúdo está no nosso blog e é um outro assunto.

Este material é focado em uma única coisa: como fazer os leads que já entram na sua clínica virarem pacientes que pagam pelo tratamento. Nem mais, nem menos.



UM RECADO IMPORTANTE

Se ao final da leitura você quiser ajuda para implementar tudo isso, a Looklead tem uma metodologia proprietária com 6 pilares de execução. Você pode agendar um diagnóstico gratuito no final deste guia. Sem compromisso, sem pressão, sem contrato longo de cara.



PARTE I

Diagnóstico

Por que sua agenda está furada



01. O que é uma CRC e por que ela existe

A tradução literal e a tradução prática

CRC é a sigla para Central de Relacionamento com o Cliente. Essa é a tradução literal. A tradução prática é mais reveladora: CRC é a estrutura da sua clínica que decide se o paciente vira faturamento ou vira estatística.

Toda clínica tem uma CRC, mesmo sem chamar assim. Se você tem alguém que atende o telefone, responde WhatsApp, marca consulta e faz confirmação, você tem uma CRC. A pergunta é se essa CRC está estruturada para converter, ou se ela funciona no improviso.

A CRC no fluxo real do paciente

Imagine o caminho que um paciente potencial faz até a sua cadeira. Ele vê seu anúncio no Instagram, clica, é levado para um formulário, preenche nome e telefone. Nesse instante, ele deixa de ser um estranho e passa a ser um lead. É aqui que a CRC começa a existir na jornada dele.

Desse ponto em diante, quem determina se ele vira consulta agendada e paga não é a agência de marketing. É a CRC. É quem responde a mensagem, quem apresenta os horários disponíveis, quem lembra dele um dia antes, quem recebe ele na porta da clínica, quem apresenta o tratamento após a consulta inicial.

A CRC é o vaso comunicante que liga marketing (que traz o lead) à clínica (que executa o tratamento). Se esse vaso vaza, tudo o mais fica comprometido. E, na maior parte das clínicas brasileiras, ele vaza muito.

O custo real de uma CRC ruim

Nós rodamos anúncios para mais de 200 clínicas e empresas ao longo de 9 anos. A média de leads perdidos por CRC mal estruturada é assustadora.

42%

É a taxa média de perda entre lead captado e primeira consulta em clínicas que operam sem uma CRC estruturada, segundo levantamento interno da Looklead em 2025.



Isso significa que se uma clínica investe R\$ 10 mil em tráfego e recebe 200 leads, aproximadamente 84 desses leads são simplesmente perdidos por problemas de CRC. Não perdidos porque o lead não tinha interesse. Perdidos porque ninguém respondeu no tempo certo, ninguém confirmou a consulta, ninguém apresentou o tratamento direito, ninguém fez o follow-up depois.

A PERGUNTA CENTRAL

Se você reduzisse essa perda de 42% para 20%, quantos pacientes a mais você teria por mês, sem gastar um centavo a mais em anúncio? Guarde esse número. Você vai voltar a ele no final do ebook.



02. As duas naturezas da CRC: operacional e comercial

Esta é a distinção mais importante do ebook. Se você entender bem o restante do material ganha muito mais peso.

Uma CRC bem estruturada opera em duas frentes que se complementam mas que exigem competências, ferramentas e KPIs diferentes. Confundir as duas é o erro mais comum das clínicas que crescem sem organização.

Frente 1. CRC Operacional

É a recepção clássica, ampliada e profissionalizada. Sua função é garantir que o paciente que já decidiu (ou está prestes a decidir) receba o tratamento no dia certo, no horário certo, com o mínimo de fricção possível.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS

- ▶ Atender ligações e mensagens no WhatsApp da clínica
- ▶ Agendar consultas e reagendar quando necessário
- ▶ Confirmar consultas 48h antes, evitando no-show
- ▶ Receber pacientes na porta e conduzi-los até o consultório
- ▶ Gerenciar reagendamentos, cancelamentos e a agenda geral do dia
- ▶ Recuperar pacientes inativos que sumiram do fluxo

FERRAMENTAS

Agenda integrada ao WhatsApp Business, sistema de gestão (SGA), telefone fixo ou VoIP e um script padronizado de atendimento.

KPI PRINCIPAL

Taxa de comparecimento efetivo. Ou seja, do total de consultas agendadas na semana, quantas efetivamente aconteceram.

Frente 2. CRC Comercial

É a peça menos compreendida e mais estratégica de uma clínica que quer crescer com previsibilidade. Sua função é transformar leads (pessoas que demonstraram interesse) em pacientes pagantes de tratamento.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS

- ▶ Responder leads captados por marketing dentro do SLA
- ▶ Qualificar o lead: entender o que ele busca, o quanto pode pagar, o momento de decisão



- ▶ Agendar a primeira consulta, preferencialmente presencial
- ▶ Fazer follow-up de propostas de tratamento não fechadas
- ▶ Reengajar leads antigos que responderam mas não converteram
- ▶ Reportar semanalmente indicadores comerciais ao dono da clínica

FERRAMENTAS

CRM (Kommo, RD Station, HubSpot ou equivalente), WhatsApp Business, script de qualificação, calculadora de tratamento e cadência estruturada de follow-up.

KPI PRINCIPAL

Taxa de conversão de lead em paciente pagante. Ou seja, do total de leads captados no mês, quantos assinaram e pagaram efetivamente um tratamento.



A tabela que muda tudo

Colocando as duas frentes lado a lado fica claro o quão diferentes elas são.

Dimensão	CRC Operacional	CRC Comercial
Foco	Executar o agendamento e a consulta	Converter interesse em decisão de compra
Perfil do profissional	Atendimento, empatia, organização	Escuta ativa, argumentação, resiliência
Ferramenta principal	Agenda + WhatsApp Business	CRM + Cadência estruturada
Tempo de resposta ideal	Até 15 minutos	Até 5 minutos
KPI principal	Taxa de comparecimento	Taxa de conversão lead → paciente
Volume típico gerido	80-200 pacientes/mês	200-400 leads/mês
Quem se reporta a	Coordenação da clínica	Diretoria comercial
Erro mais caro	Deixar paciente sem confirmação	Deixar lead sem resposta em 24h

ERRO FUNDAMENTAL

A maioria das clínicas contrata uma recepcionista para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É como pedir para um único profissional operar dois cargos diferentes. Ambas as frentes ficam mal executadas. A CRC Comercial, especificamente, sempre fica com o pior desempenho, porque atender paciente que já está na clínica sempre parece mais urgente do que responder lead no WhatsApp.

Nas próximas seções, vamos tratar cada uma dessas frentes separadamente. Antes disso, precisamos entender por onde as coisas costumam desandar.



03. Os 7 furos silenciosos que destroem sua conversão

Esta é a parte que costuma incomodar mais os donos de clínica quando lêem. Não porque seja injusta, mas porque descreve com precisão o que está acontecendo hoje na operação. Se você reconhecer 3 ou mais desses furos na sua clínica, considere isso um sinal claro de que a CRC precisa ser refeita.

Furo 1. Demora no primeiro contato

A pesquisa clássica da Harvard Business Review sobre leads B2B mostra que a chance de qualificar um lead cai 60x se a resposta demora mais de 30 minutos. Em saúde, com decisão emocional e comparação entre clínicas, o efeito é ainda mais forte.

O padrão que vemos nas clínicas que não têm CRC estruturada: lead entra às 15h de uma sexta-feira, a recepcionista responde na segunda de manhã. Nesse intervalo, o paciente já entrou em contato com mais três clínicas e provavelmente já marcou com uma delas.

PADRÃO OBSERVADO

Em nossas auditorias, 68% das clínicas respondem o primeiro lead em mais de 4 horas. Apenas 12% respondem em menos de 15 minutos. As que respondem rápido têm, em média, 2,3x mais consultas agendadas por lead captado.

Furo 2. Confirmação inexistente ou apática

A ligação de confirmação padrão é um desperdício. O script clássico é algo como "oi, é da clínica confirmando sua consulta amanhã às 15h, tudo bem?", e o paciente responde "tudo bem" mesmo quando já decidiu que não vai. Não há valor sendo entregue no toque, então o toque não muda o comportamento.

Sem confirmação em 3 toques (48h antes, 24h antes e 2h antes) usando linguagem de valor e não de checklist, o no-show fica entre 25% e 40% na média das clínicas brasileiras. Isso significa entre 1 em cada 4 e 4 em cada 10 janelas de agenda pagas por você que ficam vazias.

Furo 3. Ausência total de qualificação

Muitas recepcionistas anotam nome, telefone e uma frase genérica sobre o motivo do contato, mas nunca fazem as perguntas que separam paciente pronto para tratar de curioso perguntando preço. As



perguntas certas são simples e o script está no capítulo 09. Fazer bem essa qualificação pode dobrar a taxa de fechamento da primeira consulta.

Furo 4. Ausência de cadência para lead que não respondeu

Este é o vazamento mais silencioso. O lead entra, não responde a primeira mensagem, e é dado como perdido. Na prática, a maioria dos leads que não respondem no primeiro toque continuam interessados. Só não é o momento deles ou eles esqueceram.

Uma cadência estruturada de 9 toques ao longo de 15 dias, com canais variados (WhatsApp, ligação, e-mail, áudio), recupera entre 20% e 30% desses leads. Sem cadência, esses 25% da base viram cadáver de CRM.

Furo 5. Apresentação de tratamento sem preparação

O dentista ou médico apresenta o tratamento no consultório com base no seu conhecimento técnico. Fala em milímetros, siglas, materiais. O paciente escuta, sorri, diz que vai pensar e vai embora. 60% desses "vou pensar" são "eu não entendi por que isso custa esse valor".

A CRC comercial deve preparar a apresentação, oferecer opções de pagamento e conduzir o fechamento com uma linguagem centrada em benefício, não em técnica. Sem esse elo, o dentista mais competente do mundo perde vendas para outra clínica só porque a outra apresenta melhor.



Furo 6. Follow-up de proposta ausente

Paciente sai da consulta com um orçamento na mão e diz que vai pensar. Sete dias depois, ninguém liga. Duas semanas depois, ninguém liga. Um mês depois, alguém eventualmente lembra dele quando a agenda está vazia. Nessa altura, ele já tratou em outro lugar.

A regra de ouro: proposta apresentada tem que virar follow-up estruturado em 24h, 3 dias, 7 dias e 15 dias. Depois desse ciclo, entra no fluxo de nutrição por conteúdo. Não deixar simplesmente para lá.

Furo 7. Nenhum indicador comercial rodando

Este é o furo que sustenta todos os outros. Sem indicadores, ninguém sabe o que está funcionando ou não. A recepcionista trabalha no improviso, o dono da clínica olha o extrato bancário e tenta adivinhar a causa da flutuação.

No próximo capítulo, você vai encontrar os 12 indicadores mínimos que uma clínica deve rodar. Sem eles, você está pilotando no escuro.

SE VOCÊ MARCOU 3 OU MAIS

Esses 7 furos costumam aparecer em conjunto. A boa notícia é que, uma vez estruturados os processos das partes II e III deste ebook, todos os 7 são fechados em paralelo. O trabalho não é feito furo por furo, é feito estruturando o sistema.



04. Como medir se a sua CRC funciona: 12 indicadores

Você não pode melhorar o que não mede. Este capítulo lista os 12 indicadores mínimos que uma CRC bem estruturada acompanha semanalmente. Se você não tem esses indicadores hoje, pare a leitura, imprima esta página e comece a coletar já esta semana. Mesmo antes de aplicar o restante do material, já vai ter clareza de onde estão os problemas maiores.

Bloco 1. Indicadores da CRC Operacional

#	Indicador	Como medir	Meta
01	Tempo médio de resposta ao paciente	Tempo entre a mensagem do paciente e a resposta da CRC	< 15 min
02	Taxa de comparecimento	Consultas realizadas / consultas agendadas na semana	> 85%
03	Taxa de no-show	Consultas com falta / consultas agendadas	< 15%
04	Taxa de reagendamento	Reagendamentos / total de agendamentos	< 20%
05	Ocupação da agenda	Horas efetivamente ocupadas / horas disponíveis	> 80%
06	Recuperação de pacientes inativos	Pacientes retornaram / contatos feitos no mês	> 15%

Bloco 2. Indicadores da CRC Comercial

#	Indicador	Como medir	Meta
07	Tempo médio de resposta ao lead	Tempo entre entrada do lead e primeiro contato feito	< 5 min
08	Taxa de resposta do lead	Leads que responderam / total de leads contatados	> 60%
09	Taxa de qualificação	Leads qualificados / leads captados no mês	> 40%
10	Taxa de agendamento	1ª consulta agendada / leads qualificados	> 50%
11	Taxa de conversão em tratamento	Tratamentos fechados / consultas realizadas	> 35%
12	CAC (Custo de aquisição de paciente)	Investimento total em mídia / pacientes pagantes novos	Depende do ticket



Como implementar isso na prática

Se você está no zero e não mede nada, comece pelos 4 indicadores mais críticos: tempo de resposta ao lead, taxa de comparecimento, taxa de conversão de lead em consulta agendada, e taxa de conversão de consulta em tratamento fechado.

Uma planilha simples com essas 4 métricas, atualizada toda sexta-feira pela CRC, já é suficiente para você começar a enxergar padrões. Depois de 3 semanas, monte o quadro completo com os 12.

PADRÃO DOS CLIENTES LOOKLEAD

Clientes que rodam o quadro completo de 12 indicadores semanalmente têm, em média, taxas de conversão 65% maiores do que os que rodam menos de 4. A diferença não é sorte. É que você não consegue melhorar o que não vê.

Plano de ação da Parte I

1. Faça o diagnóstico dos 7 furos com sua equipe. Marque quantos aparecem hoje.
2. Comece a coletar os 4 indicadores críticos ainda esta semana.
3. Não tente resolver os problemas ainda. Só meça e observe por 2 semanas.
4. Depois de 2 semanas de dados, siga para a Parte II com clareza de onde atacar primeiro.



PARTE II

CRC Operacional

A recepção que agenda, confirma e reduz faltas



05. SLA de atendimento: a regra dos 5 minutos

SLA é a sigla para Service Level Agreement, acordo de nível de serviço. Traduzindo: é o combinado interno que sua CRC segue para responder cada tipo de contato. Sem SLA, cada colaborador responde no ritmo próprio. Com SLA, todo mundo segue a mesma régua e o paciente tem experiência consistente.

Os 3 SLAs mínimos

1

Lead novo

Tempo máximo de 5 minutos

Toda vez que alguém preenche o formulário do site ou clica no anúncio do Instagram/Meta e vira lead, a CRC comercial precisa responder em até 5 minutos. Esse é o SLA mais rigoroso porque é o momento em que o paciente está com maior atenção no assunto.

2

Mensagem de paciente ativo

Tempo máximo de 15 minutos

Paciente que já é seu, que está com tratamento em andamento ou que agendou consulta recente. Aqui a régua é 15 minutos dentro do horário comercial. Fora do horário, a resposta automática precisa deixar claro quando o retorno vai acontecer.

3

Mensagem geral (dúvida, elogio, reclamação)

Tempo máximo de 2 horas

Contatos sem urgência clínica ou comercial imediata. Aqui você tem mais folga, mas nunca ultrapasse 2 horas dentro do horário comercial. Reclamação, em particular, deve pular a fila e ser tratada como paciente ativo.

Como operacionalizar isso

PASSO 1. DEFINIR O HORÁRIO COMERCIAL DA CRC

A CRC precisa ter horário definido e comunicado. O padrão que funciona bem para clínicas médias é segunda a sexta das 8h às 20h, sábados das 8h às 14h. Fora disso, resposta automática avisando quando o time volta a operar.



PASSO 2. CONFIGURAR NOTIFICAÇÕES NO CRM

A pessoa responsável precisa receber alerta imediato (som, push, cor) quando um lead novo entra ou uma mensagem de paciente ativo chega. Sem alerta, o SLA não é cumprido.

PASSO 3. TER MAIS DE UMA PESSOA TREINADA

Se só uma pessoa consegue responder, o SLA quebra sempre que ela sai para almoçar, ir ao banheiro ou tirar folga. Cadastre no mínimo 2 pessoas com acesso aos canais.

PASSO 4. AUDITAR SEMANALMENTE

Toda sexta-feira, exportar do CRM os 10 leads mais recentes e verificar o tempo real de resposta. Onde estourou o SLA? Por quê? Sem essa checagem, o SLA vira letra morta em 3 semanas.

O GANHO REAL DO SLA DE 5 MINUTOS

Nossa base de clientes mostra que clínicas que cumprem o SLA de 5 minutos para lead novo têm taxa de agendamento 2,3x maior do que as que respondem em mais de 1 hora. Cumprir esse SLA sozinho já pode dobrar sua conversão, sem mexer em nada mais.



06. Confirmação em 3 toques: como reduzir no-show em 40%

No-show é a doença silenciosa da agenda. Cada janela vazia é uma consulta paga por você que não gerou receita. Se seu no-show está em 25% ou mais, você está perdendo 1 em cada 4 janelas. Multiplicado pelo ticket médio da consulta, isso é dinheiro que sai da sua clínica todos os meses sem você perceber.

A boa notícia: reduzir no-show é a coisa mais barata e mais rápida de melhorar. Não depende de contratação, não depende de tecnologia complexa. Depende de fluxo de confirmação estruturado em 3 toques.

A regra de ouro dos 3 toques

Toque	Timing	Canal	Objetivo
T1	48 horas antes	WhatsApp	Lembrar e antecipar cancelamentos
T2	24 horas antes	WhatsApp + Ligação se necessário	Confirmação formal
T3	2 horas antes	WhatsApp	Instrução de chegada e localização

Por que 3 toques e não 1

O erro clássico é fazer só a ligação de confirmação 24h antes. O problema desse toque único: se o paciente já decidiu que não vai, ele responde "sim, tudo bem" para se livrar da conversa e simplesmente não aparece. E como você recebeu confirmação, deixa a agenda travada e não consegue reagendar outro paciente para aquele horário.

Com 3 toques bem construídos, você faz duas coisas ao mesmo tempo: antecipa desistências (para poder preencher a vaga com outro paciente) e reforça o compromisso do paciente que vai.

Scripts prontos para cada toque

TOQUE 1 · 48h antes

Canal: WhatsApp



Oi [Nome]! Aqui é a Camila, da Clínica [Nome].

Passando pra confirmar sua consulta com o Dr. [Nome do profissional].



Quinta-feira, 15/08, às 15h00



Rua [endereço], sala 402

Se por algum motivo precisar remarcar, me avisa hoje ou amanhã que eu consigo abrir a agenda de forma tranquila. Combinado?

Por que funciona: você abre a porta para o cancelamento educado. Paciente que já sabe que não vai poder tem chance de avisar com antecedência, e você libera a vaga.



TOQUE 2 · 24h antes

Canal: WhatsApp (com ligação se sem resposta em 3h)

Oi [Nome], tudo bem?

Confirma sua consulta amanhã (quinta) às 15h?

Responde só  ou  que eu já registro aqui. 🙏

Por que funciona: mensagem ultra curta, com resposta binária. Não pede esforço. Se em 3 horas não houve resposta, ligação. Não pular a ligação: paciente que não confirma ativamente 24h antes tem 3x mais chance de dar no-show.

TOQUE 3 · 2h antes

Canal: WhatsApp

[Nome], boa tarde!

Sua consulta é daqui a 2h com o Dr. [Nome]. 🦷

Como chegar: [link do Google Maps]

Estacionamento: [informação, se houver]

Ao chegar, é só falar meu nome na recepção que eu te levo até a sala. Nos vemos daqui a pouco!

Por que funciona: entrega valor prático (localização, estacionamento), reforça compromisso e humaniza o atendimento. Paciente sente que já tem alguém esperando por ele.



RESULTADO ESPERADO COM 3 TOQUES BEM EXECUTADOS

Clínicas que implementam esse fluxo relatam queda de no-show de patamares de 25-35% para 10-15%. Em uma clínica com 200 consultas por mês, isso significa 40 a 50 janelas a mais efetivamente ocupadas por mês, sem mexer em nada mais.



07. Recuperação de pacientes inativos: a mina de ouro esquecida

Toda clínica tem, no seu sistema, uma base de pacientes que passaram por lá em algum momento e nunca mais voltaram. Chamamos essa base de inativos. E chamamos isso de mina de ouro porque, na maioria das clínicas, ela nunca é trabalhada.

Pense: o custo de adquirir esse paciente já foi pago. O trabalho de fidelizar já foi feito. O que falta é uma abordagem para lembrá-lo de voltar. Ativar essa base costuma ter o menor custo de aquisição e a maior conversão do funil inteiro.

Como classificar sua base de inativos

Classificação	Critério	Abordagem sugerida
Ativo	Passou nos últimos 6 meses	Nenhuma. Já está no fluxo.
Adormecido	Não passa há 6 a 12 meses	Contato para retorno preventivo
Inativo	Não passa há 12 a 24 meses	Reengajamento com oferta especial
Frio	Não passa há mais de 24 meses	Nutrição por conteúdo, sem oferta direta

Campanha de reativação de adormecidos

Esta é a categoria com maior retorno esperado. Paciente saudável, que teve boa experiência, provavelmente só esqueceu de voltar. Um toque bem construído recupera entre 15% e 25% dessa base.

MENSAGEM DE REATIVAÇÃO · Adormecido

Canal: WhatsApp



Oi [Nome], tudo bem?

Aqui é a Camila da Clínica [Nome]. Estou dando uma olhada nos prontuários dos nossos pacientes e vi que você não passa por aqui há cerca de [X] meses.

Passei pra lembrar que o retorno preventivo é importante mesmo quando nada está incomodando (na verdade, é justamente aí que ele previne dor de cabeça futura).

Que tal a gente marcar sua avaliação de retorno? Tenho vaga na próxima terça às 10h ou quinta às 15h. Qual funciona pra você?

Campanha de reativação de inativos

Aqui o paciente pode ter tido experiência ruim, mudado de bairro, ou simplesmente ter perdido conexão. Vale abordagem menos direta, com oferta de valor real.

MENSAGEM DE REATIVAÇÃO · Inativo

Canal: WhatsApp ou E-mail

Oi [Nome]!

Aqui é a Camila da Clínica [Nome]. Estamos passando um pente fino em nossos pacientes e vi que faz um tempo que você não aparece por aqui.

Sem pressão nenhuma, só queria te falar de uma iniciativa que estamos rodando este mês: avaliação completa gratuita para pacientes que faz mais de 12 meses que não passam por aqui. Sem custo, sem compromisso.

Se fizer sentido pra você retornar, me avisa que eu abro sua agenda. Se preferir não, também tudo bem. Só queria te dar essa opção.



META REALISTA DE RECUPERAÇÃO

Trabalhando uma base de 500 adormecidos e 300 inativos com esses scripts, uma clínica típica recupera entre 90 e 130 pacientes no primeiro trimestre. Ao ticket médio de tratamento (variando de R\$ 800 para consulta simples a R\$ 5.000 para tratamentos maiores), isso pode representar entre R\$ 70 mil e R\$ 400 mil em receita adicional. Sem investimento em mídia.



08. Scripts prontos: WhatsApp, ligação, e-mail e áudio

Esta é a seção que você vai imprimir e colar na parede da CRC. São os scripts que fazem diferença no dia a dia, testados em campo por clientes da Looklead. Adapte o tom para a linguagem da sua clínica, mas mantenha a estrutura.

Cenário 1. Paciente pergunta preço direto no primeiro contato

RESPOSTA · Preço no primeiro contato

Canal: WhatsApp

Oi [Nome], tudo bom!

O valor depende do tratamento que faz sentido pra você, e isso a gente só consegue definir depois da avaliação com o [profissional].

O que dá pra te adiantar: a avaliação inicial custa R\$ [valor] e é onde a gente entende exatamente o que você precisa e monta as opções de tratamento com valores. Sem compromisso.

Consigo abrir agenda pra você essa semana? Tenho vaga [dias].

Cenário 2. Paciente diz que "vai pensar" depois da consulta

RESPOSTA · Fechamento suave após consulta

Canal: pessoal (ou WhatsApp em D+1)



Claro, é uma decisão importante e faz total sentido você querer pensar.

Só uma pergunta rápida antes de você ir: o que ficou como principal dúvida ou receio? Assim eu já anoto aqui e você pode conversar com sua família com todas as informações.

(Escuta. Deixa o paciente falar. Anota.)

Perfeito. Sobre isso, [responde a objeção específica]. Vou te ligar na [dia + horário] pra saber como você está pensando. Combinado?

Cenário 3. Paciente não responde à primeira mensagem

REENGAJAMENTO D+2 · Lead sem resposta

Canal: WhatsApp

Oi [Nome], boa tarde!

Sem cobrança, só quis dar um oi. Vi que você deixou seu contato pra saber sobre [tratamento/consulta] há alguns dias.

Faz sentido pra você agendar essa semana ou o momento já é outro? Uma linha de resposta já ajuda: quero agendar / não é o momento agora. 🙏

Cenário 4. Paciente cancelou consulta em cima da hora

REAGENDAMENTO · Cancelamento em cima da hora

Canal: WhatsApp ou ligação



Oi [Nome], tudo bem!

Recebi seu cancelamento, entendo que imprevistos acontecem. Sem problema nenhum.

Já quero deixar um horário reservado pra você pra gente não perder a continuidade. Consigo abrir uma vaga na próxima [dia] às [horário] ou na [dia] às [horário]. Qual funciona melhor?

UMA NOTA SOBRE O TOM

Todos os scripts acima são neutros e formais o suficiente para funcionar com qualquer perfil de paciente. Se sua clínica atende público mais informal, você pode relaxar a linguagem. Se atende alto padrão, mantenha exatamente como está. O que importa é a estrutura: abertura, contexto, pergunta única e clara, e disponibilidade.

Plano de ação da Parte II

1. Escreva o SLA da sua clínica em uma folha e cole na parede da CRC.
2. Implemente o fluxo de confirmação em 3 toques ainda esta semana.
3. Exporte do sistema sua base de adormecidos e inativos. Comece a reativação com 20 nomes/dia.
4. Adapte e imprima os scripts do capítulo 08. Coloque na mesa da CRC.
5. Meça, semana a semana, a evolução dos 6 KPIs operacionais do capítulo 04.



PARTE III

CRC Comercial

A função que transforma lead em paciente pagante



09. SDR e Closer: quem faz o quê

Se a Parte II foi sobre estruturar a recepção da sua clínica, a Parte III é sobre construir a função comercial. Nas clínicas de melhor performance da nossa base, essa função tem duas figuras: o SDR e o Closer. Antes de detalhar cada uma, vale entender por que a divisão importa.

Por que separar SDR e Closer

SDR é a sigla para Sales Development Representative. Closer é o profissional que fecha o tratamento. As duas funções exigem competências diferentes e, mais importante, exigem foco diferente no tempo do dia.

Quando a mesma pessoa faz as duas coisas, o que acontece na prática é o seguinte: chega um paciente na clínica pra apresentação de tratamento, o profissional para o que estava fazendo, atende, tenta fechar. Enquanto isso, entram 4 leads novos no WhatsApp que ficam sem resposta por horas. Os 4 esfriam. Você acabou de trocar 1 possível fechamento por 4 leads mortos.

A separação resolve isso. SDR foca no topo do funil (leads novos, qualificação, agendamento). Closer foca no fundo (apresentação, fechamento, follow-up de proposta).

Perfil e responsabilidades

S

SDR · Qualificação e agendamento

O primeiro contato com o lead

Responde ao lead dentro do SLA de 5 minutos, faz a qualificação inicial (perguntas de renda, urgência, tipo de tratamento buscado), agenda a primeira consulta, faz reengajamento de leads que não responderam e mantém o CRM atualizado. Perfil: comunicação clara, escuta ativa, resistência à rejeição, organização.

C

Closer · Apresentação e fechamento

Quem transforma consulta em tratamento pago

Recebe o paciente pós-consulta, apresenta o tratamento proposto pelo profissional com linguagem comercial, oferece opções de pagamento, conduz o fechamento, faz o follow-up de propostas em aberto e reporta indicadores de conversão. Perfil: senioridade, argumentação, empatia, capacidade de fechar.



E se a clínica é pequena e não tem orçamento para dois profissionais?

Comum e resolvível. A regra prática: se a clínica gera menos de 60 leads e menos de 40 pacientes novos por mês, uma pessoa pode acumular as duas funções, desde que o tempo dela seja bloqueado em janelas.

Exemplo de bloqueio típico: 8h às 11h dedicado a leads novos e reengajamento (função SDR). 11h às 12h reservado para apresentação de tratamento e fechamento (função Closer). 14h às 17h dividido conforme demanda do dia. Sem bloqueio, a função Closer sempre perde para a função SDR porque parece menos urgente.

REGRA PRÁTICA

Uma pessoa pode fazer as duas funções até ~40 pacientes novos/mês. Entre 40 e 80, divida a pessoa em blocos de tempo. Acima de 80 pacientes novos/mês, contrate um profissional dedicado para cada função. Fazer isso na hora errada custa vendas, e não estruturar isso é sempre mais caro do que contratar.



10. Cadência de 9 toques que converte 3x mais

Uma cadência é a sequência estruturada de contatos que a CRC faz com um lead ao longo do tempo. É a diferença entre "mandei uma mensagem, ele não respondeu, deu ruim" e "mandei 9 mensagens de formas diferentes ao longo de 15 dias, e 30% dos que não responderam no primeiro toque acabaram respondendo em algum deles".

A cadência que apresentamos aqui é a que aplicamos internamente e a que ensinamos aos nossos clientes. É construída em 3 princípios: canais variados (WhatsApp, ligação, e-mail, áudio), tom variado (institucional, conversacional, provocativo) e permissão explícita de saída em todos os toques.

A régua completa

Dia	Toque	Canal	Objetivo
D0	1	WhatsApp (mensagem imediata)	Confirmar recebimento e fazer 1 pergunta de qualificação
D0	2	Ligação (se não respondeu em 30 min)	Verificar intenção e agendar consulta
D0	3	E-mail (em paralelo à ligação)	Fornecer material e reforçar canal
D1	4	WhatsApp em áudio pessoal	Humanizar e reduzir resistência
D2	5	WhatsApp com material de valor	Prova social ou caso próximo
D4	6	Ligação de reengajamento	Fechar loop ou entender objeção
D7	7	WhatsApp com conteúdo útil	Reciprocidade sem venda
D10	8	E-mail com pergunta binária	Polarização (sim ou não)
D15	9	WhatsApp de encerramento digno	Fechar o loop, deixar porta aberta

As perguntas de qualificação que o SDR deve fazer

No toque 1 e no toque 2, o SDR precisa fazer perguntas curtas que ajudam a classificar o lead. As 4 perguntas essenciais:

1. Você está buscando isso pra você mesmo ou pra outra pessoa? (identifica quem é o decisor)
2. Já tem algum tratamento em andamento ou está começando do zero? (mede urgência e maturidade)



3. Chegou por indicação de alguém ou viu nosso anúncio? (mede confiança inicial e canal)
4. Você tem algum prazo em mente pra começar, ou está pesquisando ainda? (mede momento de decisão)

O IMPACTO REAL DA CADÊNCIA

Sem cadência estruturada, uma clínica típica recupera 8-12% dos leads que não responderam ao primeiro toque. Com a cadência de 9 toques executada com disciplina, esse número sobe para 22-30%. Isso pode ser a diferença entre bater a meta do mês ou não.



11. Como apresentar tratamento: venda consultiva

Este é o momento mais crítico do funil comercial. Paciente chegou até a clínica, foi atendido pelo profissional, recebeu diagnóstico e proposta de tratamento. A partir daqui, quem determina se ele fecha ou vai embora é o Closer da CRC.

A maioria das clínicas trata esse momento como "apresentação de orçamento". O paciente pega uma folha com valor total, opções de parcelamento, sai da clínica dizendo que vai pensar, e 60% deles nunca voltam.

O padrão que funciona é diferente. Chamamos de venda consultiva.

Os 5 passos da venda consultiva

1

Ancorar valor antes do preço

Antes de apresentar qualquer número, o Closer precisa fazer o paciente enxergar o valor do resultado. Perguntas como "o que muda na sua vida quando esse tratamento estiver pronto?" ou "há quanto tempo você convive com isso?" ativam a percepção emocional do problema antes de apresentar o custo racional da solução.

2

Apresentar em blocos, não em folha única

Ao invés de entregar uma folha de papel com o valor total, o Closer conduz a apresentação verbalmente, bloco a bloco: bloco 1 (o que vamos fazer), bloco 2 (por que essa é a melhor abordagem para o seu caso), bloco 3 (quanto isso custa e como você pode pagar). Só quando os dois primeiros blocos foram absorvidos é que o valor entra na conversa.

3

Oferecer sempre 3 opções

A regra clássica: sozinha, qualquer proposta parece cara. Comparada, a proposta do meio quase sempre é a escolhida. Ofereça sempre 3 caminhos: uma opção completa premium, uma intermediária balanceada, e uma parcial focada apenas na urgência. Isso desloca a decisão de "faço ou não faço" para "qual eu escolho".



4

Facilitar o sim, dificultar o não

Formas de pagamento variadas, entrada baixa, primeira sessão marcada na hora. Cada barreira removida aumenta a taxa de fechamento. Do outro lado: se o paciente disser "vou pensar", perguntar diretamente o que precisa ser pensado. Não deixar a conversa terminar sem entender a objeção real.

5

Não deixar a proposta esfriar

Se o paciente sair sem fechar, cadência de follow-up disparada automaticamente: D+1 mensagem cordial, D+3 ligação com respeito à objeção específica, D+7 nova proposta ou material educativo, D+15 último toque com oferta especial se ainda faz sentido. Depois disso, entra em nutrição.



Script pronto para apresentação de tratamento

ROTEIRO · Apresentação de tratamento

Duração: 15 a 25 minutos

Abertura: "[Nome], antes de qualquer valor, quero entender como você recebeu o diagnóstico do Dr. [Nome]. Ficou alguma dúvida sobre o que ele explicou?"

Ancoragem de valor: "Deixa eu te fazer uma pergunta: se esse [problema] estiver resolvido daqui a 6 meses, o que muda no seu dia a dia?" (escutar e anotar as respostas reais)

Bloco 1 · O que: "O tratamento que a gente vai propor pra você tem 3 etapas: [descrever]. Cada etapa serve pra [benefício]."

Bloco 2 · Por que: "Escolhemos esse caminho porque no seu caso [razão específica]. Se a gente fosse pelo caminho A, o risco seria [X]. Se fosse pelo B, você teria [Y]."

Bloco 3 · Investimento: "Tenho aqui 3 formas de a gente estruturar isso. Deixa eu apresentar as três e você me diz qual faz mais sentido pra sua realidade."

Fechamento: "Baseado no que você me disse sobre [prioridade dele], eu pessoalmente indicaria a opção [X]. Faz sentido pra você? Se sim, a gente pode marcar sua primeira sessão pra semana que vem."

IMPACTO OBSERVADO

Clientes Looklead que treinaram a CRC comercial em venda consultiva relatam aumento médio de 40% na taxa de conversão de consulta em tratamento fechado. Não é milagre, é estrutura. O paciente compra melhor quando enxerga valor antes de enxergar preço.



12. Objeções mais comuns e como responder

Cada Closer bem treinado tem, na cabeça, um repertório de respostas para as objeções mais frequentes. Você não precisa reinventar. Aqui estão as 6 objeções que aparecem em quase toda apresentação, e as respostas que funcionam.

Objeção 1. "Está caro"

O padrão errado: baixar o preço na hora. Isso ensina o paciente que seu preço é negociável e o próximo também tenta.

O padrão certo: reancorar o valor antes de conversar sobre preço. "Entendo. Deixa eu te perguntar uma coisa: comparado ao que você está pagando, considerando que esse tratamento vai durar [X] anos, você acha que o problema em si vale mais ou menos do que esse investimento?"

Se realmente for questão de fluxo de caixa, oferecer opção intermediária ou parcelamento estendido, mas sem descontar o valor cheio.

Objeção 2. "Vou pensar"

O padrão errado: aceitar passivamente e deixar o paciente ir. Estatística cruel: 60% dos "vou pensar" nunca voltam.

O padrão certo: perguntar o que precisa ser pensado. "Claro, é uma decisão importante. Só uma pergunta: o que ficou como principal dúvida? Assim eu já anoto e você leva a informação completa pra conversar em casa." A resposta a essa pergunta é ouro, porque revela a objeção real.

Objeção 3. "Preciso conversar com meu marido/esposa"

O padrão errado: marcar uma nova consulta pra semana seguinte e esperar. O paciente não vai voltar.

O padrão certo: propor uma ligação em 3. "Ótimo, faz sentido incluir ele/ela nessa decisão. Que tal a gente fazer uma videochamada rápida amanhã com os três juntos? Assim ele/ela tira as dúvidas direto comigo, sem você ter que virar mensageiro." Isso resolve 40% dos casos e evita a perda por telefone-sem-fio.

Objeção 4. "Quero pesquisar em outras clínicas"



O padrão errado: ofender-se ou pressionar.

O padrão certo: encorajar a comparação de forma inteligente. "Faz total sentido. Pesquisa mesmo. Só uma dica: quando comparar, olhe 3 coisas: quantos anos de experiência tem o profissional, qual é a garantia do tratamento, e o que está incluso no valor (algumas clínicas cobram sessão a sessão, aqui é tudo incluso). Assim você compara maçã com maçã." Você educou o paciente para comparar de forma que te favorece.



Objeção 5. "Vou tentar pelo convênio primeiro"

O padrão errado: desqualificar o convênio de saída.

O padrão certo: reconhecer a lógica financeira e trazer o argumento clínico. "Faz sentido, é um valor a menos no seu bolso mesmo. Deixa eu só te falar 2 coisas antes: pelo convênio, você vai ter que passar por [X etapas burocráticas], pode demorar entre [Y semanas]. E, mais importante: no seu caso específico, o tratamento indicado pelo Dr. tem [aspecto que o convênio não cobre]. Vale considerar isso na conta."

Objeção 6. "Preciso ver se cabe no meu orçamento"

O padrão errado: entregar o boleto e aguardar.

O padrão certo: virar isso em conversa. "Perfeito. Deixa eu te propor uma coisa: a gente vê juntos aqui quanto ficaria por mês nas 3 formas de pagamento, e você me diz qual dessas cabe. Assim não fica no ar. Aceita?" Trazer a conversa financeira para o momento presente, não deixar o paciente sair sem clareza numérica.

A REGRA DE OURO DAS OBJEÇÕES

Toda objeção é um pedido disfarçado de mais informação. Quando o paciente diz "está caro", ele está dizendo "não tenho clareza suficiente do valor para justificar esse preço". Quando ele diz "vou pensar", ele está dizendo "faltou algo na sua apresentação". Um Closer bem treinado escuta objeção como oportunidade, não como fim de linha.

Plano de ação da Parte III

6. Defina hoje se sua clínica precisa de SDR e Closer separados ou de bloqueio de tempo em uma pessoa.
7. Implemente a cadência de 9 toques no CRM. Se não tem CRM, é a hora de contratar.
8. Treine sua equipe em venda consultiva usando o script do capítulo 11.
9. Imprima o mapa de objeções do capítulo 12 e revise mensalmente com o time.
10. Meça semanalmente os 6 KPIs comerciais do capítulo 04.



PARTE IV

Implementação

Como sair do zero e estruturar uma CRC de alta performance em 30 dias



13. Roadmap de 30 dias, semana por semana

Se você chegou até aqui, provavelmente está pensando: "ok, entendi tudo, mas por onde eu começo?". Este capítulo responde isso. É um roadmap testado, com etapas semanais, para você sair do zero e ter uma CRC funcionando em 30 dias corridos.

Aviso importante: você não precisa terminar tudo em 30 dias. Se sua clínica tem mais complexidade, use o roadmap como referência de sequência, não como cronômetro rígido. O que importa é a ordem, não a velocidade.

Semana 1. Diagnóstico e fundação

SEGUNDA A QUARTA

- ▶ Reúna sua equipe atual e aplique o diagnóstico dos 7 furos do capítulo 03
- ▶ Comece a coletar manualmente os 4 KPIs críticos (tempo de resposta a lead, taxa de comparecimento, agendamento e conversão)
- ▶ Defina qual pessoa (existente ou nova) assumirá formalmente a CRC. Se possível, alguém dedicado.

QUINTA E SEXTA

- ▶ Escreva o SLA formal (5 min lead, 15 min paciente ativo, 2h mensagem geral)
- ▶ Configure o WhatsApp Business com respostas rápidas para as 5 perguntas mais comuns
- ▶ Se ainda não tem CRM, contrate um esta semana (Kommo, RD Station ou similar)

Semana 2. Operacional em pleno funcionamento

SEGUNDA A QUARTA

- ▶ Ative o fluxo de confirmação em 3 toques descrito no capítulo 06
- ▶ Adapte e imprima os scripts do capítulo 08. Coloque na mesa da CRC.
- ▶ Exporte do sistema sua base de adormecidos e inativos

QUINTA E SEXTA

- ▶ Comece a campanha de reativação de adormecidos: 20 contatos por dia
- ▶ Configure notificações no CRM para alertar sobre novos leads
- ▶ Faça a primeira medição semanal dos 6 KPIs operacionais

Semana 3. Comercial estruturado



SEGUNDA A QUARTA

- ▶ Cadastre a cadência de 9 toques do capítulo 10 no seu CRM
- ▶ Treine seu SDR (ou a pessoa que acumula) nas 4 perguntas de qualificação
- ▶ Comece a aplicar a cadência para todos os leads novos que entram

QUINTA E SEXTA

- ▶ Faça workshop interno com o profissional de saúde e o Closer sobre venda consultiva (capítulo 11)
- ▶ Estabeleça o ritual de reunião comercial semanal (30 minutos, toda sexta às 17h)
- ▶ Imprima o mapa de objeções do capítulo 12 e distribua para o time



Semana 4. Refinamento e escala

SEGUNDA A QUARTA

- ▶ Analise os KPIs completos (12) após 3 semanas de dados
- ▶ Identifique o KPI mais fraco e crie um plano de ataque específico
- ▶ Ajuste scripts e cadência com base no que os dados mostraram

QUINTA E SEXTA

- ▶ Escreva o playbook interno da CRC (10-15 páginas) baseado no que funcionou até aqui
- ▶ Treine uma pessoa reserva para cobrir folgas e ausências
- ▶ Faça a primeira apresentação de resultados para a diretoria

O QUE ESPERAR AO FINAL DOS 30 DIAS

Clínicas que seguiram esse roadmap com disciplina relatam, em média: no-show reduzido em 30-40%, tempo de resposta a lead abaixo de 15 minutos, taxa de agendamento aumentada em 25-40% e primeiros pacientes recuperados da base de adormecidos. Nada disso é milagre, é execução.

Timeline visual

Semana	Foco principal	Entregável mínimo
Semana 1	Diagnóstico e fundação	SLA escrito, KPIs sendo coletados, CRM contratado
Semana 2	Operacional funcionando	Confirmação em 3 toques ativa, reativação de adormecidos iniciada
Semana 3	Comercial estruturado	Cadência de 9 toques rodando, time treinado em venda consultiva
Semana 4	Refinamento e escala	Playbook da CRC escrito, primeiros resultados medidos



14. Ferramentas essenciais

Você não precisa de tecnologia sofisticada para ter uma CRC de alta performance. Precisa das ferramentas certas para os processos certos. Este capítulo lista o mínimo indispensável.

Grupo 1. Comunicação com paciente e lead

Ferramenta	Custo aproximado	Por que é essencial
WhatsApp Business	Gratuito	Multi-usuário, respostas rápidas, catálogo, etiquetas para segmentação
VoIP ou telefone fixo	R\$ 50-200/mês	Ligações sem custo alto e possibilidade de gravação
E-mail marketing	R\$ 100-300/mês	Automação de nutrição para leads em estágio inicial

Grupo 2. Gestão e organização

Ferramenta	Custo aproximado	Por que é essencial
CRM (Kommo, RD, HubSpot)	R\$ 300-1.500/mês	Registro de cada lead, cadência automatizada, relatórios
Sistema de gestão da clínica	R\$ 300-800/mês	Agenda, prontuário, faturamento (Dental Office, Clinicorp etc.)
Planilha de KPIs semanais	Gratuito	Enquanto CRM e SGA não integram bem, planilha resolve

Grupo 3. Dashboard e visibilidade

Ferramenta	Custo aproximado	Por que é essencial
Google Looker Studio	Gratuito	Dashboard visual dos 12 KPIs com atualização automática
Notion ou Google Docs	Gratuito ou R\$ 50/mês	Playbook interno, scripts, roteiros, treinamento



UMA NOTA SOBRE INTEGRAÇÕES

O grande gargalo tecnológico das clínicas é integrar CRM com sistema de gestão. Enquanto essa integração não existe, use uma planilha compartilhada preenchida manualmente uma vez por semana. Não deixe de medir por causa de tecnologia. Perfeição é inimigo do progresso.



15. Como treinar seu time em 5 dias

O treinamento da CRC não precisa ser longo. Um plano de 5 dias, com blocos de 2 horas, cobre 90% do que uma pessoa precisa saber para operar bem. Aqui está a estrutura que a Looklead usa nos treinamentos internos que faz para clientes.

Dia 1. Fundamentos

- ▶ O que é CRC e por que ela existe (leitura conjunta dos capítulos 01 e 02)
- ▶ Diagnóstico dos 7 furos aplicado à sua clínica (capítulo 03)
- ▶ Apresentação dos 12 KPIs e como eles serão coletados (capítulo 04)
- ▶ Dinâmica final: cada pessoa lista 3 furos que reconhece na sua rotina

Dia 2. Operacional

- ▶ SLA de atendimento e como respeitar as janelas (capítulo 05)
- ▶ Fluxo de confirmação em 3 toques com role-play em duplas (capítulo 06)
- ▶ Recuperação de inativos com base real (capítulo 07)
- ▶ Prática com scripts do capítulo 08

Dia 3. Comercial

- ▶ SDR e Closer: papéis e responsabilidades (capítulo 09)
- ▶ Cadência de 9 toques: prática de cada toque com casos reais (capítulo 10)
- ▶ As 4 perguntas de qualificação com role-play
- ▶ Cada participante roda a cadência completa em um lead simulado

Dia 4. Venda consultiva

- ▶ Os 5 passos da venda consultiva (capítulo 11)
- ▶ Role-play de apresentação de tratamento com o script completo
- ▶ Mapa de objeções: cada pessoa responde às 6 objeções em voz alta (capítulo 12)
- ▶ Simulação de 3 apresentações completas por participante



Dia 5. Ferramentas e prática ao vivo

- ▶ Configuração hands-on do CRM
- ▶ Configuração do WhatsApp Business e respostas rápidas
- ▶ Cada participante atende 3 leads reais sob supervisão
- ▶ Retrospectiva da semana, plano de melhoria individual

SOBRE RECICLAGEM

Treinamento não é evento único. Depois dos 5 dias iniciais, faça reciclagem mensal de 2 horas focada no KPI que está pior. Trimestralmente, revise scripts e cadências com base nos dados coletados. Sem reciclagem, o treinamento inicial perde 40% do efeito em 90 dias.



16. Cases reais: como chegaram lá

Para fechar a Parte IV, três cases da nossa base que ilustram tudo o que foi apresentado neste ebook. Números reais, com contexto de mercado e o que foi feito na CRC especificamente.

Case 1. Sorrix Andrômeda · Expansão de rede

Contexto: rede odontológica com sede em Andradina/SP. Em 2022 tinha 1 clínica. Em 2025 chegou a 7 unidades operando.

Antes da Looklead: dependência quase total de indicação, agenda oscilante, dificuldade em prever faturamento mensal, no-show em torno de 30%.

O que foi feito na CRC:

- ▶ Reestruturação da CRC comercial com SDR dedicado e treinamento em cadência de 9 toques
- ▶ Implementação do fluxo de confirmação em 3 toques (reduziu no-show para 12%)
- ▶ Integração completa entre tráfego, CRM e agenda
- ▶ Rotina semanal de KPIs comerciais reportada à diretoria

Resultado: expansão de 1 para 7 unidades em 3 anos, previsibilidade de agenda pela primeira vez na história da rede, redução de CAC em 45%.

Case 2. CECAM Cardiologia · Aumento de exames particulares

Contexto: clínica de diagnóstico médico especializada em cardiologia, com forte volume de convênio e desejo de aumentar participação de exames particulares (ticket maior, margem melhor).

O que foi feito na CRC:

- ▶ Segmentação da CRC: uma pessoa para convênio (fluxo alto e recorrente) e outra para particular (ticket maior, ciclo comercial mais longo)
- ▶ Treinamento específico em venda consultiva para o time do particular
- ▶ Cadência de reengajamento para pacientes que fizeram exame por convênio mas eram elegíveis para complementares particulares

Resultado: aumento de 30% em receita de exames particulares em 6 meses, sem reduzir volume de convênio.



Case 3. The Wand · Venda de equipamentos odontológicos

Contexto: distribuidora de equipamentos odontológicos, ciclo comercial de 30-60 dias, ticket médio alto.

O que foi feito na CRC:

- ▶ Cadência estendida para 30 dias (12 toques ao longo de um mês, adaptada ao ciclo mais longo)
- ▶ Follow-up de proposta com apresentação técnica em videochamada
- ▶ KPIs comerciais reportados semanalmente à liderança de vendas

Resultado: aumento de 37% em vendas de equipamentos em 4 meses.

"Nichos totalmente diferentes. Mesmo método. Mesmos resultados."



Encerramento: seu próximo movimento

Você chegou até o final. Isso, sozinho, já te coloca acima da média. A maioria dos donos de clínica pega este tipo de material, lê a introdução e para. Você foi diferente.

Agora, uma pergunta honesta: você vai aplicar?

A diferença entre o dono de clínica que continua reclamando de agência que só posta e o dono que constrói uma operação previsível não está no acesso à informação. Está no que ele faz com a informação.

Você tem duas opções agora.

Opção 1. Implementar sozinho

Volte ao capítulo 13 e comece pela semana 1. Envolve sua equipe. Colete os 4 KPIs críticos. Aplique os scripts. Cometa erros, ajuste, aprenda. Em 90 dias você deve ter uma CRC funcionando em nível decente. Em 6 meses, em nível bom.

Opção 2. Fazer com quem já fez isso 200 vezes

A Looklead é a agência por trás dos cases da Sorrix, CECAM e The Wand que você acabou de ler. Nossa metodologia proprietária, o Método LEAD, integra tráfego pago, estruturação de CRC, treinamento de time e dashboards de indicadores em um só sistema.

Diferente da agência tradicional que "vai testar", a gente entra com o método completo, o time treinado e os processos já validados. A curva de aprendizado que você levaria 6 meses para atravessar sozinho, a gente atravessa junto com você em 30 dias.

DIAGNÓSTICO GRATUITO LOOKLEAD

Uma conversa de 40 minutos, sem compromisso, onde a gente entra no seu caso, calcula o potencial de aquisição da sua clínica e desenha o caminho. Você sai da call com um plano na mão. Se fizer sentido continuar com a gente, ótimo. Se não, o plano é seu de todo jeito. Agende em: looklead.com.br · WhatsApp: +55 11 94251-0995



"Escalar não significa investir mais. Significa construir um sistema previsível de aquisição, qualificação e conversão."



LOOKLEAD

Marketing · CRM · Dados · Resultados

A agência por trás dos maiores cases de aquisição do setor de saúde

+R\$ 8 milhões

em anúncios geridos

+R\$ 300 milhões

em receita gerada para nossos clientes

+200 empresas

aceleradas em 9 anos de operação

looklead.com.br

Google Partner · Meta Business Partner · ABF